

Support clinique DPL-TDAH

Repérage et évaluation de première ligne du TDAH de l'adulte

Guide d'appui au raisonnement et à l'entretien pour les psychiatres de première ligne.

Préambule

Ce guide aide le psychiatre de première ligne à mener un bilan TDAH de l'adulte : traiter les cas simples, repérer les cas complexes à orienter, et réduire les délais d'accès au spécialisé. Il s'inscrit dans le **DPL-TDAH des Makaras (CH Valvert)**.

Trois principes

En télé-expertise. Les Makaras ne reçoivent pas en consultation pour le TDAH, ce support concerne la demande diagnostique.

Un appui, pas un test. Aucun score ne diagnostique seul : on vise une convergence de signes anciens (avant 12 ans), persistants, présents dans ≥ 2 contextes et retentissants, le différentiel écarté.

La comorbidité est la règle. Cartographier les troubles associés autant qu'écarter ce qui explique mieux le tableau — sans méconnaître ni sur-diagnostiquer.

Repères DSM-5-TR à garder en tête (adulte)

- **Symptômes** : ≥ 5 sur 9 dans un domaine (inattention et/ou hyperactivité-impulsivité), depuis ≥ 6 mois.
- **Âge d'apparition** : plusieurs symptômes présents avant 12 ans.
- **Contextes** : présents dans ≥ 2 milieux de vie (travail, domicile, relations...).
- **Retentissement** : altération fonctionnelle cliniquement significative.
- **Différentiel** : symptômes non mieux expliqués par un autre trouble.

Le guide en bref.

Le cœur du support repose sur deux temps d'évaluation :

- **Partie 1 : entretien clinique avec le patient** (inspiré de la DIVA-5, environ 30 minutes) ;
- **Partie 2 : recueil développemental auprès d'un proche** ayant connu le patient avant l'âge de 12 ans.

Le recueil auprès d'un proche est **fortement recommandé**. Le questionnaire **peut être complété à distance par un parent, un membre de la fratrie ou tout autre proche ayant bien connu le patient durant son enfance**, puis être transmis au médecin par l'intermédiaire du patient.

Le reste du document constitue un appui à la réflexion clinique et peut être consulté selon les besoins :

- **Annexe A** : critères DSM-5-TR ;
- **Annexe B** : diagnostics différentiels et comorbidités ;
- **Annexe C** : grille d'observation clinique.

Ce support sert également de trame pour la télé-expertise, dont l'issue peut être : **TDAH retenu, TDAH non retenu** ou **ré-orientation vers professionnels du réseau**.



▶ Les drapeaux rouges — signes évocateurs

Aucun signe n'est spécifique isolément : c'est leur **accumulation**, leur **ancienneté** et leur **retentissement** qui font sens.

Domaine	Manifestations évocatrices
Histoire développementale	Difficultés scolaires précoces sans autre cause, présentes aussi au domicile (et pas seulement à l'école) ; élève « intelligent mais dispersé » ; remarques répétées sur l'inattention ou l'agitation ; désorganisation dès l'enfance
Inattention persistante	Décrochages en conversation ou en lecture ; distractibilité ; oublis quotidiens ; difficultés de concentration
Fonctions exécutives	Désorganisation chronique ; difficulté à planifier et à prioriser ; procrastination ; tâches non terminées
Gestion du temps	Retards fréquents ; mauvaise estimation des durées ; fonctionnement dans l'urgence
Impulsivité	Interruptions ; décisions rapides regrettées ; difficulté à attendre ; prise de risques ; parle beaucoup ; dysrégulation émotionnelle
Hyperactivité / agitation	Agitation interne ; besoin de stimulation ; difficulté à ne rien faire ; multitâche permanent
Retentissement fonctionnel	Décalage chronique entre le potentiel et les réalisations — souvent au premier plan du vécu ; difficultés professionnelles et relationnelles ; désorganisation du quotidien
Compensation	Recours à des stratégies peu efficaces (listes, alarmes) non tenues sur la durée ; fonctionnement « sous pression » ; fatigue
Instabilité du parcours	Parcours scolaire ou professionnel instable ; changements fréquents de projets ; sentiment de vie inachevée
Variabilité contextuelle	Amélioration en situation stimulante ; aggravation dans les tâches monotones
Antécédents familiaux	TDAH, autres troubles du neurodéveloppement, addictions chez les apparentés

● Drapeau rouge majeur

Un décalage chronique, depuis l'enfance, entre le potentiel et le fonctionnement quotidien : symptômes anciens, persistants, présents dans plusieurs contextes, avec un retentissement réel.

🔍 Présentations sous-repérées

Plus difficile à repérer quand le TDAH est compensé : forme à prédominance inattentive (sans hyperactivité visible), plus souvent décrite chez les femmes ; symptômes masqués par des stratégies d'adaptation coûteuses, un bon niveau intellectuel ou un environnement contenant ; plainte d'abord anxieuse, dépressive ou d'épuisement. **Y penser quand la demande émerge tardivement, après plusieurs diagnostics partiels.**

⚙️ Critères de complexité

- Situations dépassant la première ligne → avis spécialisé*
- Comorbidité psychiatrique **sévère ou instable** (bipolarité non stabilisée, psychose, addiction active, risque suicidaire)
 - Suspicion de **TSA** ou de **déficience** intellectuelle associée
 - Diagnostic différentiel **non tranché après l'évaluation**
 - Psychotraumatisme complexe** ; échecs thérapeutiques répétés
 - Enjeux médico-légaux ou experts**

⚠️ Pièges fréquents

- Autodiagnostic via les réseaux** : la conviction du patient n'est pas un argument diagnostique
- Sur-endossement des auto-questionnaires (ASRS / WURS) : **un score élevé ne suffit pas**, surtout après documentation en ligne
- Sur-attribution au TDAH de symptômes non spécifiques** (inattention, agitation) sans écarter anxiété, dépression ou troubles du sommeil
- Méconnaître la comorbidité**, ou le **différentiel bipolaire avant tout psychostimulant**



Partie 1 — Support d'entretien clinique

Inspiré de la DIVA-5 · à conduire avec le patient · 30 min (au maximum 2 × 30 min)

Consigne pour le médecin évaluateur

Cet entretien recueille de façon structurée les symptômes évocateurs d'un TDAH de l'adulte. Pour chaque item, cochez la fréquence habituelle du symptôme à deux périodes : dans l'enfance (avant 12 ans) d'après le patient et à l'âge adulte (6 derniers mois).

Cotez l'état de base du patient, en dehors des épisodes aigus (dépression, manie / hypomanie, anxiété sévère, intoxication ou sevrage). Lisez l'item, appuyez-vous sur la reformulation et sur les questions clés en main, puis cochez. L'appui sur votre connaissance du patient est un atout ; gardez une posture souple pour éviter l'effet "formulaire".

① reformulation simple de l'item. questions clés en main. **Significatif** = coté "Souvent" ou "Très souvent" à l'âge adulte.

A · Symptômes d'inattention

		Jamais	Parfois	Souvent	Très souvent
1. Erreurs d'inattention, détails négligés	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① Fautes d'étourderie, détails manqués dans le travail ou les tâches précises, malgré l'effort. « Avez-vous souvent du mal à prêter attention aux détails, ou faites-vous des erreurs d'étourderie dans votre travail ? Et enfant, dans le travail scolaire ? » « Vous a-t-on déjà dit que votre travail manquait de soin, ou que vous alliez trop vite ? »					
2. Difficulté à soutenir l'attention	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① L'attention décroche sur la durée : lecture, réunion, conversation, film. « Trouvez-vous difficile de maintenir votre attention sur une tâche ? Et enfant, sur un jeu ou en classe ? » « Pouvez-vous suivre un film jusqu'au bout, finir un livre — ou décrochez-vous ? »					
3. Semble ne pas écouter	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① L'esprit s'évade quand on s'adresse à lui, même sans distraction extérieure. « Donnez-vous souvent l'impression de ne pas écouter quand on vous parle directement ? Et dans l'enfance ? » « Vous dit-on que vous êtes "ailleurs", qu'il faut répéter ou hausser la voix ? »					
4. N'achève pas, ne suit pas les consignes	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① Commence mais ne finit pas ; perd le fil des consignes ou des étapes. « Avez-vous du mal à suivre les consignes et à mener vos tâches à terme (maison, travail) ? Et enfant, le travail scolaire ? » « Commencez-vous des choses sans les finir ? Combien de projets en cours en ce moment ? »					
5. Difficulté à organiser	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① Peine à planifier, ordonner les tâches, gérer le temps et le matériel ; travail désordonné. « Trouvez-vous difficile d'organiser vos tâches ou vos activités ? Et dans l'enfance ? » « Planifiez-vous, ou faites-vous dans l'urgence ? Votre espace de travail est-il en désordre ? »					



6. Évite l'effort mental soutenu	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① Repousse ou fuit ce qui demande une concentration prolongée : paperasse, dossiers, lecture. 🗨 « Évitez-vous (ou faites-vous à contrecœur) les tâches qui demandent un effort mental soutenu ? Et enfant, les devoirs ? » « Repoussez-vous la paperasse, les dossiers, la lecture longue ? Lesquels en particulier ? »					
7. Perd des objets	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① Égare régulièrement les objets nécessaires : clés, téléphone, papiers, matériel. 🗨 « Perdez-vous souvent les objets nécessaires à votre travail ou vos activités ? Et dans l'enfance ? » « Clés, téléphone, papiers : combien de temps passez-vous à les chercher ? »					
8. Facilement distrait	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① Distrait par l'environnement — ou par ses propres pensées qui partent ailleurs. 🗨 « Vous laissez-vous facilement distraire par ce qui se passe autour de vous ? Et dans l'enfance ? » « Êtes-vous aussi distrait par vos propres pensées ? Avez-vous du mal à reprendre le fil ? »					
9. Oublis dans le quotidien	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① Oublie rendez-vous, obligations, rappels, démarches courantes. 🗨 « Oubliez-vous souvent ce que vous avez à faire au quotidien ? Et dans l'enfance ? » « Rendez-vous, factures, courses : vous faut-il beaucoup de rappels et de listes ? »					

Synthèse — Inattention

Items cotés **Souvent / Très souvent** à l'âge adulte : ____ / 9 Repère : domaine significatif si **≥ 5 / 9**, présence compatible dans l'enfance. Oriente, ne vaut pas diagnostic.

B · Symptômes d'hyperactivité / impulsivité

		Jamais	Parfois	Souvent	Très souvent
1. Remue, ne tient pas en place	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① Bouge mains ou pieds, se tortille, change de position ; chez l'adulte, agitation souvent discrète. 🗨 « Remuez-vous souvent les mains ou les pieds, tapotez-vous, vous tortillez-vous sur votre siège ? Et dans l'enfance ? » « Arrivez-vous à contrôler cette agitation, mais au prix d'une tension intérieure ? »					
2. Se lève, ne reste pas assis	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
① Difficulté à rester assis quand c'est attendu : réunion, repas, cinéma. 🗨 « Vous levez-vous souvent quand on attend que vous restiez assis ? Et enfant, en classe ou à table ? » « Évitez-vous les réunions, préférez-vous marcher plutôt que rester assis ? »					



3. Agitation intérieure, besoin de bouger	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
ⓘ Impatience motrice interne difficile à contrôler — équivalent adulte du “court/grimpe partout” de l’enfance. ☞ « Vous sentez-vous souvent agité ? Et dans l’enfance ? » « Est-ce une agitation intérieure, un trop-plein d’énergie difficile à apaiser ? »					
4. Difficulté à se poser, loisirs calmes	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
ⓘ Mal à faire quelque chose tranquillement, à se détendre sans bruit ni activité. ☞ « Trouvez-vous difficile de profiter tranquillement d’un moment de détente ? Et enfant, dans les jeux calmes ? » « Arrivez-vous à ne rien faire, ou vous faut-il toujours une activité ? »					
5. Toujours “sur la brèche”	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
ⓘ Comme “mû par un moteur” : toujours quelque chose à faire, du mal à s’arrêter. ☞ « Êtes-vous souvent “sur la brèche”, comme “mû par un moteur” ? Et dans l’enfance ? » « Avez-vous toujours quelque chose à faire, du mal à vous arrêter ? »					
6. Parle trop, a du mal à se retenir	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
ⓘ Flot de parole excessif, difficile à freiner. ☞ « Parlez-vous souvent trop ? Et dans l’enfance ? » « Vous dit-on que vous parlez sans arrêt, qu’on a du mal à en placer une ? »					
7. Répond avant la fin	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
ⓘ Lâche la réponse trop tôt, termine les phrases des autres, anticipe. ☞ « Laissez-vous souvent échapper la réponse avant la fin de la question ? Et dans l’enfance ? » « Finissez-vous les phrases des autres ? Dites-vous les choses sans réfléchir ? »					
8. Difficulté à attendre son tour	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
ⓘ Supporte mal l’attente : files, tours de parole. ☞ « Trouvez-vous souvent difficile d’attendre votre tour ? Et dans l’enfance ? » « Files d’attente, embouteillages, tours de parole : est-ce pénible, êtes-vous impatient ? »					
9. Interrompt, s’impose	Enfance (< 12 ans)	☐	☐	☐	☐
	Adulte (6 mois)	☐	☐	☐	☐
ⓘ Coupe la parole, s’immisce dans les activités ou conversations des autres. ☞ « Interrompez-vous souvent les autres ou imposez-vous votre présence ? Et dans l’enfance ? » « Vous immiscez-vous dans ce que font les autres ? Vous dit-on que vous êtes intrusif ? »					

Synthèse — Hyperactivité / impulsivité

Items cotés **Souvent / Très souvent** à l’âge adulte : ____ / 9 Repère : domaine significatif si **≥ 5 / 9**, présence compatible dans l’enfance. Oriente, ne vaut pas diagnostic.



C · Critères développementaux

	Oui	Non
Plusieurs symptômes étaient-ils présents avant l'âge de 12 ans ?	☐	☐
Étaient-ils observés dans plusieurs contextes durant l'enfance (école, maison, activités) ?	☐	☐
Les symptômes persistent-ils actuellement ?	☐	☐
Sont-ils présents dans plusieurs domaines de vie actuels (travail, domicile, relations) ?	☐	☐

D · Retentissement fonctionnel global

Domaine	Aucun	Léger	Modéré	Important	Sévère
Travail / Études	☐	☐	☐	☐	☐
Organisation du quotidien	☐	☐	☐	☐	☐
Vie familiale / Couple	☐	☐	☐	☐	☐
Relations sociales	☐	☐	☐	☐	☐
Gestion administrative et financière	☐	☐	☐	☐	☐
Autonomie (logement, vie seule)	☐	☐	☐	☐	☐
Estime de soi / Qualité de vie	☐	☐	☐	☐	☐



Partie 2 — Témoignage d'un proche

Période avant 12 ans (entrée au collège, 6e/5e) · proche ayant connu le patient enfant

Pourquoi & comment

Le TDAH débute dans l'enfance. Ce volet recueille le **regard d'un proche** (idéalement un parent) **sur la période avant 12 ans** (entrée au collège, 6e/5e) ; il complète la Partie 1. **Proche interrogé** ou **questionnaire autonome** (un exemple par comportement présent +/- un témoignage)

Proche : _____ Lien : ☐ Parent ☐ Fratrie ☐ Autre : _____

Connu(e) enfant de _____ à _____ Modalité : ☐ Interrogé(e) ☐ Questionnaire seul(e)

A · Inattention dans l'enfance

COMPORTEMENT DANS L'ENFANCE (< 12 ANS)	Jamais	Parfois	Souvent	Très souvent
1. Faisait des erreurs d'étourderie à l'école	☐	☐	☐	☐
① <i>Étourderies, détails manqués dans le travail scolaire ; travail souvent "bâclé".</i> 🗨 « Faisait-il/elle des erreurs d'étourderie en classe, dans ses devoirs ? Son travail était-il peu soigné, fait trop vite ? » « Les enseignants notaient-ils un travail négligé, des fautes d'inattention ? » <i>Exemple / illustration :</i>				
2. Du mal à maintenir son attention	☐	☐	☐	☐
① <i>Difficulté à rester concentré(e) en classe, sur un jeu, un devoir ; vite lassé(e).</i> 🗨 « Tenait-il/elle son attention en classe, sur un jeu, un devoir — ou décrochait-il/elle vite ? » « Se lassait-il/elle vite, passait-il/elle d'une activité à l'autre ? » <i>Exemple / illustration :</i>				
3. Semblait ne pas écouter	☐	☐	☐	☐
① <i>"Dans la lune", rêveur(se) ; il fallait répéter, élever la voix, un contact visuel.</i> 🗨 « Donnait-il/elle l'impression de ne pas écouter quand on lui parlait ? Fallait-il souvent répéter ? » « Était-il/elle souvent "dans la lune", rêveur(se) ? » <i>Exemple / illustration :</i>				
4. Ne suivait pas les consignes, ne finissait pas	☐	☐	☐	☐
① <i>Du mal à suivre des consignes à plusieurs étapes ; ne terminait pas ses devoirs.</i> 🗨 « Finissait-il/elle ses devoirs ? Suivait-il/elle les consignes jusqu'au bout ? » « Avait-il/elle du mal quand une tâche comportait plusieurs étapes ? » <i>Exemple / illustration :</i>				
5. Du mal à s'organiser	☐	☐	☐	☐
① <i>Cartable et chambre en désordre ; mal à planifier ses tâches, ses devoirs.</i> 🗨 « Était-il/elle organisé(e) — cartable, chambre, devoirs — ou plutôt en désordre ? » « Avait-il/elle besoin qu'on l'aide à ranger, à planifier ? » <i>Exemple / illustration :</i>				
6. Évita l'effort mental soutenu	☐	☐	☐	☐
① <i>Rechignait aux devoirs ; détestait les matières demandant de la concentration.</i> 🗨 « Rechignait-il/elle aux devoirs, aux tâches qui demandent de se concentrer longtemps ? » « Repoussait-il/elle ou abandonnait-il/elle ce qui demandait un effort prolongé ? » <i>Exemple / illustration :</i>				
7. Perdait ses affaires	☐	☐	☐	☐
① <i>Égarait matériel scolaire, jouets, vêtements ; on lui faisait remarquer qu'il/elle perdait tout.</i> 🗨 « Perdait-il/elle souvent ses affaires (matériel scolaire, vêtements, jouets) ? » « Passait-il/elle du temps à les chercher, en oubliait-il/elle à l'école ? » <i>Exemple / illustration :</i>				



8. Facilement distrait(e)	☐	☐	☐	☐
ⓘ En classe, regardait dehors ; distrait(e) par les bruits ; du mal à reprendre le fil. ☞ « Était-il/elle facilement distrait(e) en classe, par ce qui se passait autour ? » « Regardait-il/elle souvent dehors, décrochait-il/elle au moindre bruit ? » ✎ Exemple / illustration :				
9. Oublis du quotidien	☐	☐	☐	☐
ⓘ Oubliait consignes, corvées, affaires à l'école ; on devait souvent lui rappeler les choses. ☞ « Oubliait-il/elle ses affaires, les consignes, ce qu'il/elle devait faire ? Fallait-il rappeler sans cesse ? » « Oubliait-il/elle ses corvées, ce qu'on venait de lui demander ? » ✎ Exemple / illustration :				

B · Hyperactivité / impulsivité dans l'enfance

COMPORTEMENT DANS L'ENFANCE (< 12 ANS)	JAMAIS	PARFOIS	SOUVENT	TRES SOUVENT
1. Remuait, ne tenait pas en place	☐	☐	☐	☐
ⓘ Remuait mains/pieds, se tortillait ; on lui disait souvent "tiens-toi tranquille". ☞ « Remuait-il/elle sans cesse, se tortillait-il/elle ? Lui disait-on souvent de se tenir tranquille ? » « Tapotait-il/elle, jouait-il/elle avec des objets, bougeait-il/elle mains et pieds ? » ✎ Exemple / illustration :				
2. Se levait, ne restait pas assis	☐	☐	☐	☐
ⓘ Se levait pendant les repas, quittait sa place en classe ; très difficile de rester assis. ☞ « Restait-il/elle assis(e) à table, en classe — ou se levait-il/elle sans arrêt ? » « Quittait-il/elle sa place quand il fallait rester assis ? » ✎ Exemple / illustration :				
3. Agité(e), toujours en mouvement	☐	☐	☐	☐
ⓘ Courait, grimpait, sautait partout quand ce n'était pas approprié ; agité(e) de l'intérieur. ☞ « Était-il/elle toujours en mouvement — court, grimpe, saute — même quand il fallait être calme ? » « Grimpait-il/elle partout, semblait-il/elle infatigable ? » ✎ Exemple / illustration :				
4. Du mal à jouer ou se poser tranquillement	☐	☐	☐	☐
ⓘ Incapable de jouer calmement ; parlait fort en jouant ; on lui demandait de se calmer. ☞ « Pouvait-il/elle jouer ou regarder quelque chose tranquillement, sans bruit ? » « Lui demandait-on souvent de se calmer, de baisser d'un ton ? » ✎ Exemple / illustration :				
5. "Sur la brèche", débordait d'énergie	☐	☐	☐	☐
ⓘ Constamment occupé(e), "monté(e) sur ressorts" ; difficile à suivre. ☞ « Débordait-il/elle d'énergie, toujours occupé(e), "monté(e) sur ressorts" ? » « Le trouvait-on difficile à suivre, toujours partant pour bouger ? » ✎ Exemple / illustration :				
6. Parlait trop	☐	☐	☐	☐
ⓘ "Moulin à paroles" ; enseignants demandant de se taire ; bulletins mentionnant des bavardages. ☞ « Parlait-il/elle beaucoup trop ? Les enseignants ou bulletins mentionnaient-ils des bavardages ? » « Était-il/elle un(e) "moulin à paroles", difficile à interrompre ? » ✎ Exemple / illustration :				
7. Répondait avant la fin, sans réfléchir	☐	☐	☐	☐
ⓘ Voulait répondre le premier ; donnait la première réponse venue ; coupait les phrases.				



- « Répondait-il/elle avant la fin des questions, coupait-il/elle la parole, sans réfléchir ? »
« Voulait-il/elle toujours répondre le premier, lançait-il/elle la première réponse venue ? »

Exemple / illustration :

8. Du mal à attendre son tour

☐
☐
☐
☐

① Du mal à attendre son tour en classe, dans les jeux de groupe ; impatient(e).

- « Avait-il/elle du mal à attendre son tour (jeux, classe, file) ? Était-il/elle impatient(e) ? »
« Coupait-il/elle la file, voulait-il/elle passer avant les autres ? »

Exemple / illustration :

9. Interrompait, s'imposait

☐
☐
☐
☐

① Interrompait les jeux/conversations des autres ; utilisait leurs affaires sans demander.

- « Interrompait-il/elle les autres, s'imposait-il/elle dans leurs jeux ou conversations ? »
« Utilisait-il/elle les affaires des autres sans demander, dérangeait-il/elle leurs activités ? »

Exemple / illustration :

Témoignage libre (optionnel) — comment était le patient avant 12 ans :



Annexe A — Zoom DSM-5-TR

Le diagnostic ne repose pas sur le seul décompte des symptômes : il exige la réunion des cinq critères (A à E). Le décompte oriente, les critères B à E tranchent.

LES 18 SYMPTOMES — CRITERE A

Inattention (déficit attentionnel)	Hyperactivité / impulsivité
☐ 1. Erreurs d'inattention, détails négligés	☐ 1. Remue, ne tient pas en place
☐ 2. Difficulté à soutenir l'attention	☐ 2. Se lève, ne reste pas assis
☐ 3. Semble ne pas écouter	☐ 3. Agitation intérieure / besoin de bouger
☐ 4. N'achève pas, ne suit pas les consignes	☐ 4. Difficulté à se poser, loisirs calmes
☐ 5. Difficulté à organiser	☐ 5. Toujours « sur la brèche »
☐ 6. Évite l'effort mental soutenu	☐ 6. Parle trop
☐ 7. Perd des objets	☐ 7. Répond avant la fin
☐ 8. Facilement distrait	☐ 8. Difficulté à attendre son tour
☐ 9. Oublis dans le quotidien	☐ 9. Interrompt, s'impose

Seuil adulte : au moins 5 symptômes sur 9 dans un domaine (à partir de 17 ans), **contre 6/9 chez l'enfant**, présents depuis **au moins 6 mois**.

LES CINQ CRITERES EN PRATIQUE

Critère	Exigence	Point de vigilance / illustration
A Symptômes	≥ 5 symptômes sur 9 dans un domaine chez l'adulte (≥ 17 ans) — 6/9 chez l'enfant —, présents depuis ≥ 6 mois, à un degré inadapté au développement.	Ne pas compter un symptôme expliqué par une simple opposition ou une incompréhension de la consigne .
B Âge d'apparition	Plusieurs symptômes (inattention et/ou hyperactivité-impulsivité) présents avant l'âge de 12 ans.	Le DSM-5-TR n'exige plus de <i>retentissement</i> avéré avant 12 ans, seulement la présence de symptômes — utile chez l'adulte compensé.
C Contextes	Symptômes présents dans au moins 2 milieux de vie (domicile, travail/études, relations, autres activités).	Une difficulté limitée à un seul contexte oriente vers une cause situationnelle .
D Retentissement	Preuve d'un retentissement cliniquement significatif (social, scolaire/professionnel, qualité de vie).	C'est le retentissement , plus que le simple décompte, qui fait la pertinence clinique .
E Exclusion	Symptômes ne survenant pas exclusivement lors d'une schizophrénie/d'un trouble psychotique, et non mieux expliqués par un autre trouble (humeur, anxiété, dissociatif, personnalité, intoxication/sevrage).	C'est l'objet de l'Annexe B : écarter ce qui explique mieux — et cartographier ce qui s'associe.

PRESENTATIONS CLINIQUES & SEVERITE

Présentation (selon les domaines remplis sur les 6 derniers mois) : combinée (F90.2) · inattentive prédominante (F90.0) · hyperactive-impulsive prédominante (F90.1).

Sévérité : **légère** (peu de symptômes au-delà du seuil, retentissement mineur) · **modérée** (intermédiaire) · **sévère** (nombreux symptômes ou particulièrement marqués, retentissement net).

En rémission partielle : critères **complets antérieurs**, désormais **incomplets depuis 6 mois**, mais **retentissement persistant**.



Annexe B — Diagnostics différentiels & comorbidités

De nombreux symptômes attribués au TDAH ne sont pas spécifiques. Devant chaque tableau, le clinicien se pose deux questions complémentaires :

1. « **Mieux expliqué par ?** » — écarter ce qui rend mieux compte du tableau (différentiel).
2. « **Associé à ?** » — car la comorbidité est la règle : il faut la cartographier, pas seulement l'exclure.

CARTOGRAPHIER LES COMORBIDITES FREQUENTES

- ☐ Tb anxieux ☐ Tb dépressif ☐ Tb bipolaire ☐ Addictions / substances / TCA
☐ Tb du sommeil ☐ Tb de la personnalité ☐ TSA ☐ Tb (dys) ☐ Tics

PRINCIPAUX DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS

Diagnostic	Ce qui peut faire évoquer un TDAH	Ce qui oriente plutôt vers ce diagnostic
Trouble du spectre de l'autisme (TSA)	Maladresses sociales, désorganisation, distractibilité apparente, hyperfocalisation, agitation	Difficultés de communication sociale depuis l'enfance (au-delà de l'impulsivité verbale), intérêts spécifiques intenses , besoin de routines
Trouble anxieux généralisé	Difficulté de concentration, oublis, agitation mentale	Inquiétudes excessives et persistantes au premier plan , qui expliquent l'inattention ; pas d'ancienneté développementale
Trouble dépressif	Inattention, ralentissement, désorganisation	Début plus tardif , humeur triste, perte d'intérêt ; fluctue avec les épisodes ; attention conservée entre les épisodes
Trouble bipolaire	Impulsivité, agitation, distractibilité	Symptômes épisodeques (début/fin, retour à l'état de base). ⚠ À écarter avant tout psychostimulant.
Personnalité obsessionnelle-compulsive	Tâches non terminées, désorganisation secondaire	Perfectionnisme, rigidité, besoin de contrôle, souci excessif du détail
Trouble obsessionnel-compulsif	Distractibilité liée aux obsessions, difficultés de concentration	Obsessions et/ou compulsions clairement identifiables
Personnalité borderline	Impulsivité, instabilité émotionnelle	Peur de l'abandon, relations instables, labilité liée au contexte relationnel ; pas depuis l'enfance
État de stress post-traumatique	Inattention, agitation, troubles exécutifs	Antécédent traumatique , hypervigilance, reviviscences, évitement, dissociation ; pas de trouble attentionnel avant le trauma
Usage d'alcool ou de substances	Inattention, impulsivité, désorganisation	Chronologie liée à la consommation ou au sevrage
Haut potentiel intellectuel (non pathologique)	Pensée rapide, ennui, distractibilité	Pas de déficit exécutif global ni d'histoire développementale compatible avec un TDAH
Burn-out professionnel	Désorganisation, oublis, fatigue cognitive	Début lié à une surcharge chronique ; amélioration au retrait du facteur stressant
Troubles du sommeil (apnée, insomnie...)	Fatigue, oublis, baisse d'attention	Somnolence diurne, sommeil non réparateur ; symptômes fluctuant selon le sommeil

Vigilance bipolarité : Avant d'envisager un psychostimulant, écarter un trouble bipolaire non reconnu : l'impulsivité et la distractibilité épisodeques peuvent en imposer pour un TDAH, et un psychostimulant risque de précipiter un virage (hypo)maniaque.



Annexe C — Grille d'observation clinique

① Mode d'emploi

À cocher après l'entretien, d'après ce que vous avez observé. Repère d'appoint : des signes nets **soutiennent** l'hypothèse, mais une observation pauvre **n'exclut pas** un TDAH — le face-à-face, nouveau et stimulant, atténue souvent les symptômes en consultation.

Observé pendant l'entretien	Non observé	Discret	Net
🧑‍🚶 Activité motrice			
Bouge sur le siège, se tortille ; mains ou jambes agitées	☐	☐	☐
Manipule des objets, tapote, joue avec un stylo	☐	☐	☐
Se lève ou change souvent de position ; tient mal en place	☐	☐	☐
🎯 Attention dans l'échange			
Perd le fil, fait répéter les questions	☐	☐	☐
Distract par des stimuli externes (bruit, passage, téléphone)	☐	☐	☐
Regard qui s'évade, paraît « ailleurs »	☐	☐	☐
Digresse, répond à côté, difficile à recadrer sur le sujet	☐	☐	☐
⚡ Impulsivité			
Interrompt, termine les phrases de l'interlocuteur	☐	☐	☐
Répond avant la fin des questions	☐	☐	☐
Coupe la parole, s'impose dans l'échange	☐	☐	☐
📁 Organisation			
Récit décousu, chronologie imprécise	☐	☐	☐
Documents en désordre ; oublis (pièces demandées, rendez-vous)	☐	☐	☐
Retard à la consultation	☐	☐	☐
🗣️ Communication / affect			
Débit verbal excessif, logorrhée	☐	☐	☐
Impatience, labilité émotionnelle	☐	☐	☐

Synthèse de l'observation

Impression globale : ☐ Peu d'éléments observés ☐ Quelques signes ☐ Signes nets et convergents

Notes :

Rappel : une observation normale n'écarte pas le diagnostic ; à confronter aux Parties 1 et 2 et au reste du faisceau d'arguments.